PROTOCOLLO 1

Anamnesi strutturata nel paziente con DTM

Raccogliere in modo ordinato i dati che orientano diagnosi e trattamento

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Tutti i quadri	15 a 20 minuti	Prima visita

Indicazioni

- ✓ Primo accesso del paziente con dolore orofacciale
- ✓ Invio da odontoiatra, gnatologo o medico
- ✓ Ripresa del trattamento dopo una lunga pausa

Controindicazioni e precauzioni

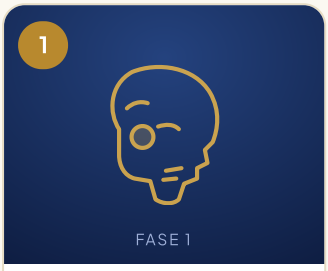
- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, in un ambiente tranquillo, con tempo sufficiente per raccontare la propria storia.

Fisioterapista: di fronte al paziente, con la scheda anamnestica e il modulo del consenso informato.

Esecuzione passo dopo passo



Motivo della visita

Chiedi il problema principale con parole del paziente e da quanto tempo è presente.



Caratteristiche del dolore

Sede, intensità, andamento nella giornata, fattori che aggravano e alleviano.



Funzione

Indaga masticazione, apertura, rumori, blocchi e abitudini parafunzionali.



Contesto

Sonno, stress, cefalea, sintomi cervicali, terapie dentali e farmaci in corso.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Strumento	Scheda anamnestica DTM e diagramma del dolore
Tempo	15 a 20 minuti
Aggiornamento	a ogni rivalutazione

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Lascia raccontare il paziente prima di fare domande chiuse
- ✓ Registra il dolore con una scala numerica da 0 a 10
- ✓ Annota sempre le terapie odontoiatriche in corso

Errori da evitare

- ! Partire subito dall'esame fisico
- ! Trascurare sonno, stress e cefalea
- ! Non chiedere i sintomi nelle ultime 30 giornate

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Diario dei sintomi	Annotare dolore, rumori e situazioni scatenanti ogni sera	per 7 giorni prima della seconda seduta

! **Nota clinica.** Un'anamnesi accurata permette di formulare già un'ipotesi del quadro DC/TMD prima dell'esame fisico.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.